MÓDULO 7 · INVESTIGACIÓN CLÍNICA, RWE Y GENERACIÓN DE EVIDENCIA

Plan de generación de evidencia

Un plan de generación de evidencia es el documento estratégico que traduce las preguntas de investigación prioritarias de un producto —muchas de ellas identificadas como gaps de evidencia— en un conjunto coordinado de estudios y actividades, con objetivos, cronograma y responsables definidos. Es, en esencia, la hoja de ruta que asegura que la evidencia que se genera responde a una estrategia deliberada y no a iniciativas aisladas y descoordinadas.

PLAN DE GENERACIÓN DE EVIDENCIA

- Documento estratégico que traduce preguntas prioritarias en estudios coordinados
- Incluye objetivos, cronograma y responsables definidos
- Asegura una estrategia deliberada, no iniciativas aisladas y descoordinadas

Según los marcos de referencia de organizaciones como la Medical Affairs Professional Society (MAPS), un plan de generación de evidencia integrado combina distintos tipos de actividad de forma sinérgica: estudios clínicos de Fase IIIb y IV que amplían el conocimiento sobre el producto en poblaciones o comparadores no cubiertos por los pivotales; estudios iniciados por el investigador que responden a preguntas surgidas de la comunidad científica externa; iniciativas de recogida de datos del mundo real y colaboraciones con registros de enfermedad; y estudios de resultados en salud y economía de la salud que generan la evidencia necesaria para las decisiones de acceso y reembolso. La clave de un buen plan no es la cantidad de estudios, sino su coherencia: cada actividad debe estar justificada por una pregunta estratégica concreta, y el conjunto debe cubrir, de forma equilibrada, las necesidades de evidencia científica, de acceso al mercado y de práctica clínica.

Plan integrado de evidencia (MAPS)

→ **Estudios Fase IIIb/IV**
→ **Estudios iniciados por el investigador**
→ **RWD y registros**
→ **Estudios HEOR**

El proceso de construcción de un plan de generación de evidencia sigue típicamente varias etapas: primero, la identificación y priorización de gaps de evidencia, con aportación directa del terreno a través de los insights del equipo de MSL; segundo, la definición de objetivos de evidencia específicos, medibles y con un horizonte temporal claro; tercero, el diseño metodológico de las actividades necesarias para cada objetivo, decidiendo qué tipo de estudio (intervencional, observacional, registro, análisis secundario de bases de datos) responde mejor a cada pregunta; y cuarto, la asignación

de recursos, cronograma y gobernanza, incluyendo los comités de revisión científica que aprueban cada actividad.

LAS 4 ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN

1. **Identificar gaps**
   Priorizarlos con aportación directa de insights del MSL
2. **Definir objetivos**
   Específicos, medibles y con horizonte temporal claro
3. **Diseñar metodología**
   Decidir qué tipo de estudio responde mejor a cada pregunta
4. **Asignar recursos**
   Cronograma y gobernanza, incluyendo comités de revisión

El MSL participa en este proceso principalmente en dos momentos. En la fase de identificación de gaps y priorización, aportando la perspectiva sistematizada del terreno —lo que realmente preguntan y necesitan los KOLs y clínicos—. Y en la fase de ejecución y difusión, apoyando la relación con investigadores en estudios en marcha, y ayudando a que los resultados generados lleguen, una vez publicados, a la comunidad científica relevante a través de la comunicación científica no promocional.

LOS 2 MOMENTOS DE PARTICIPACIÓN DEL MSL

1. **Identificación de gaps**
   Aporta la perspectiva sistematizada del terreno
2. **Ejecución y difusión**
   Apoya la relación con investigadores y la difusión de resultados

Un plan de generación de evidencia bien ejecutado tiene un efecto compuesto a lo largo del ciclo de vida del producto: cada estudio que responde a un gap real genera nueva evidencia, que a su vez puede revelar nuevas preguntas, alimentando un ciclo continuo de generación de conocimiento que mantiene al producto —y a la conversación científica de Medical Affairs sobre él— relevante y creíble mucho más allá del momento de su aprobación inicial.

- Tiene un efecto compuesto a lo largo del ciclo de vida del producto
- Cada estudio que responde a un gap real genera nueva evidencia y nuevas preguntas
- Mantiene al producto y a Medical Affairs relevantes y creíbles